

HISTERIA TRAUMÁTICA Y PARÁLISIS POR SUGESTIÓN

Tres piezas de las lecciones de 1885

Leçons sur les maladies du système nerveux faites à la Salpêtrière

Tomo III · París, Progrès Médical / Delahaye et Lecrosnier, 1887

Autor: Jean-Martin Charcot (1825-1893).

Obra: *Leçons sur les maladies du système nerveux*, tomo III, lecciones XX, XXII y XXVI. Lecciones dictadas en la Salpêtrière en 1885 y recogidas por P. Marie, G. Guinon y G. Gilles de la Tourette.

Traducción: Cátedra de Psicopatología I, UFLO Online, 2026, desde el original francés, que es de dominio público.

Establecimiento del texto: ejemplar digitalizado de la edición original (Internet Archive, id. *oeuvrescompltesd03char*).

Advertencia: este **no** es el texto que el programa cita por la compilación de J. Saurí. Es otro texto de Charcot, elegido porque contiene el argumento que esta clase necesita.

Unidad: Unidad 2 — El síntoma y la histeria · Clase 5.

Por qué leemos este texto

De todo lo que Charcot escribió sobre la histeria, esto es lo que más cerca está de Dora, y no por el tema sino por el problema. Aquí Charcot se encuentra con síntomas corporales —un brazo paralizado, una voz perdida— que no tienen ninguna lesión detrás. Y en lugar de descartarlos, hace dos cosas.

La primera es mostrar que ese brazo paralizado **no obedece a la anatomía**. La anestesia de Porcz... se detiene en líneas geométricas que no corresponden al territorio de ningún nervio: una línea circular alrededor del brazo, como un brazalete. El síntoma sigue el dibujo que el enfermo tiene de su propio cuerpo, no el mapa de los nervios.

La segunda es más audaz: **reproduce el síntoma**. A una paciente hipnotizada le sugiere que no puede mover el hombro, y no puede; le sugiere el codo, y tampoco; y cada vez que paraliza un segmento, la anestesia se extiende hasta ese segmento y no más allá. Después compara el dibujo obtenido con el del enfermo real y encuentra que son superponibles. Luego lo deshace todo con una sugestión de sentido contrario.

Lo que queda demostrado, delante del auditorio, es que **una representación produce un síntoma en el cuerpo** — y que se lo puede quitar del mismo modo. Es el hecho del que sale todo el psicoanálisis: si el síntoma obedece a una idea, la pregunta clínica pasa a ser cuál es esa idea, de qué escena viene y a quién se dirige. Charcot produce la idea desde afuera y no pregunta nada; Freud supondrá que la idea ya estaba adentro, y solo preguntará.

La tercera pieza es la que más directamente prepara la clase. Dora tiene afonía: pierde la voz durante semanas. Acá van a encontrar esa misma afonía descrita como síndrome, distinguida de la lesión orgánica y reproducida experimentalmente. Charcot la describe con una precisión admirable y nunca le pregunta qué quiere decir. Freud va a preguntarle exactamente eso, y la respuesta —que

cuando el señor K. se ausentaba no tenía sentido hablar— es donde empieza nuestra clase.

PIEZA I · El brazo que no obedece a la anatomía

[Lección XX. Charcot presenta a un enfermo cuyo diagnóstico había dividido a la Société médicale des hôpitaux: ¿contusión del plexo braquial o histeria?]

La lección de hoy estará consagrada al estudio clínico de un caso de monoplejía braquial derecha, sobrevenida hace algunos meses en un hombre de 25 años a raíz de una caída sobre el hombro; monoplejía que presenta para el diagnóstico dificultades muy serias. Esas dificultades, señores, no las exagero por gusto.

Se trata de un hombre de 25 años, llamado Porcz..., que ejerce la profesión de cochero de fiacre y que entró en el servicio de la clínica el 15 de abril último. La afección data de hace más de cuatro meses. [A los 16 años había entrado como lavador en la Compañía de coches pequeños y poco después contrajo un reumatismo articular agudo que lo retuvo seis semanas en cama.]

Existe en ese miembro, además de la parálisis del movimiento, trastornos profundos de la sensibilidad. La sensibilidad al contacto, al dolor y al frío está abolida completa, absolutamente; y esa anestesia cutánea, que ocupa por lo demás exclusivamente las partes del miembro donde hay impotencia motriz, se limita, del lado de las partes vecinas que han quedado sensibles, por líneas que ofrecen una disposición singular y —sobre todo del lado de la mano— **muy poco en relación con el modo de distribución anatómica de los nervios cutáneos del miembro superior.**

Vean, en efecto, que sobre el dorso de la mano el límite de la anestesia está marcado, del lado de los dedos, por una línea perpendicular al gran eje del miembro, situada algunos centímetros por encima de la serie de las articulaciones metacarpofalángicas, mientras que sobre la cara palmar ese límite está representado por una línea paralela al pliegue de la muñeca y situada por debajo de ese pliegue, a un centímetro aproximadamente. La insensibilidad, por lo demás, no se limita a la piel: se extiende a las partes profundas.

[Y el contraste con lo que se observaría si hubiera lesión de los nervios:] en la contusión del plexo braquial la zona de anestesia corresponde al territorio de los nervios alcanzados, hay trastornos tróficos y hay modificación de las reacciones eléctricas de los músculos paralizados. En nuestro enfermo no hay trastornos tróficos ni modificación alguna en las reacciones eléctricas.

PIEZA II · La parálisis producida y deshecha

[Lección XXII. Charcot ha hipnotizado a una paciente, Greuz..., y le ha sugerido una parálisis del miembro superior. Ahora se propone algo más fino.]

Henos aquí ya en posesión de datos incontestablemente muy preciosos. Pero nos está permitido llevar el análisis más lejos. En efecto, en lugar de paralizar el miembro entero de una sola vez, podremos paralizarlo parcialmente, segmento por segmento, y esas operaciones sucesivas, van a verlo, nos harán penetrar en cierto modo más adentro aún en la intimidad de los fenómenos.

Para llegar a eso nos hace falta antes que nada —permítanme la expresión— «desparalizar» a nuestra enferma. Nos bastará para ello destruir los efectos de la sugestión inicial haciendo intervenir una sugestión nueva de sentido contrario. Afirmando entonces a Greuz... que su brazo ha dejado de estar paralizado, que puede de nuevo moverlo como lo hacía antes. Ven que después de algunos instantes de discusión el miembro ha recuperado en efecto todas las funciones del estado normal, tanto desde el punto de vista de la motilidad como en lo que concierne a la sensibilidad considerada en todos sus

modos.

En primer lugar, sugiero a la enferma la idea de que le resulta imposible mover la articulación del hombro, y he aquí que en realidad no puede ya moverla en ninguna dirección, mientras mueve libremente todas las otras juntas: el codo, la muñeca y por fin los dedos. Además, sobre toda la parte donde el movimiento voluntario está abolido —y solo allí, adviértanlo bien— la sensibilidad cutánea y profunda está apagada: sobre el muñón del hombro las punzaduras y las excitaciones farádicas no son percibidas; los movimientos de torsión y de distensión, aun violentos, impresos a la articulación escapulohumeral no hacen experimentar ningún dolor, ninguna sensación.

No dejará de tener interés considerar de cerca la extensión y los límites de esa anestesia. El departamento insensible representa en cierto modo **una placa moldeada sobre el hombro, que recuerda la pieza de las armaduras del siglo XVI destinada a proteger esa región**. El brazo casi entero está contenido en la zona de anestesia que, para continuar la comparación, parece formarle **un verdadero brazalete**. Llamo particularmente su atención sobre el modo singular en que se limita por abajo esa placa anestésica: la línea determinada por punzaduras sucesivas y muy próximas es muy netamente circular; limita un plano horizontal ficticio perpendicular al eje del miembro.

Vamos a ver las cosas modificarse si, por el mismo procedimiento de sugestión, determinamos ahora la parálisis de los movimientos de la articulación del codo. Apenas la impotencia motriz se ha vuelto completa para esa junta, ven que la zona de anestesia se ha extendido inmediatamente hacia abajo: ocupa actualmente no solo el hombro y el brazo, sino también el codo y el antebrazo; su límite inferior está constituido por una línea circular horizontal situada unos dos traveses de dedo por encima de la muñeca, determinando esta vez también un plano perpendicular al gran eje del miembro.

Pasemos a otro segmento, el de la muñeca. También allí, a consecuencia de una nueva sugestión análoga a las precedentes, la parálisis no se hace esperar, de modo que en este momento el sujeto no puede mover ya ni su hombro, ni su codo, ni en fin su muñeca: solo los dedos de la mano se mueven libremente. En consecuencia, el límite inferior de la zona de anestesia se encuentra desplazado una vez más.

Ahora bien, señores —y es aquí adonde sobre todo quería llegar—, resulta que la parálisis que acabamos de determinar en Greuz... por una serie de sugestiones sucesivas **reproduce, hasta en los menores detalles, los caracteres clínicos que presenta la monoplejía de nuestro enfermo Porcz...**

En efecto, en los dos casos es exactamente sobre los mismos segmentos del miembro superior —hombro, codo, muñeca— que recae la impotencia motriz, quedando los movimientos de los dedos perfectamente libres; y en los dos casos igualmente, en todas partes donde existe la parálisis del movimiento hay anestesia cutánea y profunda y pérdida de las nociones del sentido muscular, mientras que los dedos, que han conservado sus movimientos, no presentan ningún trastorno de la sensibilidad. La imitación que hemos obtenido es perfecta; se extiende, lo repito, hasta los detalles más minuciosos. Si comparan el territorio de anestesia de nuestro sujeto hipnotizado con el del enfermo Porcz..., verán que esos territorios ofrecen exactamente la misma extensión, la misma configuración; casi diría que **son superponibles**.

PIEZA III · La voz perdida

[Lección XXVI. Charcot presenta dos enfermos juntos: uno tiene una lesión bulbar orgánica de pronóstico fatal; el otro, un mutismo histérico. Los expone uno al lado del otro para que el contraste enseñe.]

Sumariamente, los rasgos comunes son los siguientes: los dos enfermos están colocados, el uno en la imposibilidad absoluta, el otro en la casi imposibilidad de expresar su pensamiento por el lenguaje articulado; además, ambos son afónicos. La afonía del primero es absoluta: apenas le es posible emitir, y aun con los mayores esfuerzos, un pequeño grito ronco.

Agregaré que uno y otro han conservado el lenguaje mímico en su plena integridad; se podría conversar con ellos por señas, pero la conversación será singularmente facilitada por intermedio de la escritura. No solamente nuestros enfermos están en plena posesión de su inteligencia y comprenden admirablemente lo que se les dice, sino que además pueden muy bien traducir su pensamiento escribiendo, exactamente como lo hacían antes del desarrollo de la enfermedad, es decir, en un estilo y con una ortografía acordes con la educación que han recibido.

Este muchacho de 33 años, que ejerce actualmente la profesión de gasista, presenta un ejemplo notable de lo que se designa generalmente con el término de *mutismo histérico*.

En la gran mayoría de los casos, el mutismo histérico comienza súbitamente. **Sobreviene a consecuencia de un susto, de una emoción viva de naturaleza cualquiera;** se lo ve producirse a veces al salir de un ataque histérico; o bien también, sin causa provocadora aparente, en el curso de la afonía histérica. Puede en fin desarrollarse durante el curso de una laringitis vulgar. Su duración es extremadamente variable: unas veces de algunas horas, de algunos días apenas —en nuestro enfermo existe desde hace tres semanas.

[Charcot desarrolla luego los caracteres que hacen del mutismo histérico un grupo clínico autónomo, el modo de desenmascarar a los simuladores y la producción experimental del síndrome en histéricas hipnotizables.]

[Fin del recorte.]

Aparato de cátedra

Lo que sigue no pertenece a Charcot: es material de la cátedra.

Una advertencia sobre cómo leer la pieza II

Que Charcot produzca una parálisis por sugestión puede llevar a una conclusión apresurada: que sus histéricas estaban amaestradas por el servicio y que todo el cuadro era un artificio del hospital. Esa fue exactamente la objeción de la escuela de Nancy, y no es trivial. Pero conviene no confundir dos cosas. Que un síntoma pueda ser producido por una idea no significa que sea fingido: significa que las ideas tienen efectos en el cuerpo. El hallazgo no es que la histérica actúe, sino que una representación pueda paralizar un brazo de verdad. Freud tomará ese hecho y no la sospecha.

Tres cosas para tener localizadas

En el texto	Qué muestra Charcot	Qué hará Freud con eso
El brazalete de Porcz...	La anestesia se limita por líneas circulares perpendiculares al eje del miembro, sin relación con el territorio de los nervios.	En 1893 lo formulará así: la histeria se comporta como si la anatomía no existiera. El síntoma sigue la idea que el enfermo tiene de su cuerpo, no su estructura.
La parálisis segmento por segmento	Una idea sugerida paraliza el hombro; otra, el codo. La anestesia acompaña cada vez al segmento y se detiene ahí. Una sugestión contraria lo deshace todo.	Si una representación produce el síntoma, la pregunta clínica es cuál es la representación. Charcot la pone desde afuera; Freud la buscará adentro, en la historia del enfermo.

La afonía del gasista	Pérdida de la voz de comienzo súbito, tras un susto o una emoción viva, con la inteligencia intacta y la escritura conservada.	Es el síntoma de Dora. Freud no lo describirá mejor: le preguntará cuánto duraban sus ataques de tos y afonía, y cuánto duraban las ausencias del señor K.
-----------------------	--	--

Preguntas para llevar a clase

1. ¿Por qué el dibujo de la anestesia de Porcz... es un argumento diagnóstico y no un detalle descriptivo? ¿Qué queda probado cuando una parálisis no respeta la anatomía?
2. Charcot deshace la parálisis de Greuz... con «una sugestión de sentido contrario». Si el síntoma se quita hablando, ¿qué clase de cosa es el síntoma?
3. Charcot produce la idea que paraliza. Freud supondrá que la idea ya estaba ahí y que el enfermo no la sabe. ¿Qué cambia en la posición del médico entre una cosa y la otra?
4. El mutismo histérico comienza «a consecuencia de un susto, de una emoción viva». Charcot lo anota como dato etiológico y pasa a otra cosa. ¿Qué haría falta agregar a esa frase para que se volviera una pregunta clínica?

Sobre esta traducción

Traducida del francés por la cátedra. Las tres piezas provienen de lecciones distintas del mismo tomo y se presentan en el orden del argumento, no en el del libro; cada una lleva indicada su lección de origen. Los cortes y las aclaraciones de la cátedra van entre corchetes. Se conservan las abreviaturas de los nombres —Porcz..., Greuz...— tal como figuran en el original: Charcot no daba los apellidos completos de sus enfermos.